

Objectifs résidanat : Asthme de l'adulte
Pr Ag Rahma Ben Jazia – Pr Sana Aissa
Juillet 2025

1. Les corticoïdes inhalés :

- A. La dose nécessaire est indépendante du niveau de contrôle de l'asthme
- B. Peuvent donner des complications locales
- C. Est le traitement de fond de la maladie asthmatique
- D. Sont utilisés dans le traitement de l'exacerbation modérée de l'asthme
- E. Les corticoïdes par voie IV peuvent être utilisés seuls au cours d'une exacerbation d'asthme

2. Concernant la physiopathologie de l'asthme, quelles propositions sont exactes ?

- A. L'asthme a toujours une cause allergique
- B. La distension thoracique est souvent présente
- C. L'asthme fait intervenir une broncho---dilatation
- D. L'hyperréactivité bronchique intervient dans cette physiopathologie
- E. On note également une raréfaction des sécrétions glandulaires bronchique

3. La conduite à tenir chez une asthmatique de 33 ans présente un asthme partiellement contrôlé sous association budésonide 200 et forméterol 2 fois par jour :

- A. Passer directement au pallier 4 : « step up »
- B. Passer directement au pallier 3 : « step up »
- C. Vérifier la technique d'inhalation
- D. Chercher un syndrome des apnées obstructives du sommeil
- E. Diminuer la dose du budésonide à cause du risque des effets indésirables de la corticothérapie

4. Immunothérapie anti-allergénique ou spécifique (ITA ou ITS):

- A. Est indiquée chez un patient ayant des prick test positifs aux acariens, poils de chien et chat
- B. Constitue un traitement étiologique de l'asthme
- C. Induit un état de tolérance de l'organisme par l'injection de doses équivalentes d'allergènes
- D. Est indiquée chez un patient dont l'asthme est sévère et bien contrôlé
- E. Se présente sous forme d'injections sous cutanées seulement

5. En faveur d'un asthme allergique

- F. L'hyperéosinophilie sanguine est spécifique de l'allergie
- G. La présence des immunoglobulines A
- H. Des tests cutanés aux pneumallergènes positifs
- I. Une IDR à la tuberculine négative
- J. Présence des IgE spécifiques

6. Dans le traitement de l'asthme, les sympathomimétiques :

- A. Ne sont indiqués que dans la crise d'asthme sévère
- B. Peuvent entraîner des troubles cardiaques
- C. Sont à l'origine de tremblement
- D. Sont contre indiqués chez la femme enceinte
- E. La forme orale doit être préférée à la forme en spray

7. Le traitement de l'asthme allergique selon le GINA 2022 :

- A. Contient 2 schémas thérapeutiques selon le type de traitement de secours
- B. Le schéma préféré se base sur le salbutamol
- C. L'association formotérol-CSI moyenne dose est un traitement de secours
- D. Les anti leucotriènes constitue un traitement préféré
- E. Le LAMA doit être administré seul dans le pallier 5

8. L'asthme bronchique d'origine allergique :

- A. Est fréquemment du aux acariens de poussière de maison
- B. Ne comporte pas de composante familiale
- C. Peut être saisonnier
- D. S'accompagne toujours d'une augmentation des IgE
- E. Constitue une indication à une désensibilisation spécifique

9. Dans l'asthme bronchique :

- A. L'inspiration est pénible et sifflante au cours de la crise
- B. Les épreuves fonctionnelles respiratoires peuvent être normales entre les crises
- C. L'hyper réactivité bronchique est constante
- D. La toux ramène une expectoration hémoptoïque
- E. Le traitement par bronchodilatateur de longue durée d'action est toujours indiqué.

10. Au cours d'une crise d'asthme modérée, vous prescrivez :

- A. Ventoline par voie inhalée
- B. Bricanyl par voie sous cutanée
- C. Théophylline en injection intra veineuse directe
- D. Un corticoïde par voie inhalée
- E. Un corticoïde par voie injectable

11. Chez un asthmatique, les crises de dyspnée paroxystique peuvent être provoquées par :

- A. L'exercice
- B. L'émotion
- C. Exposition à de la fumée de tabac
- D. Ingestion de paracétamol
- E. Infection bronchique

12. Une femme de 25 ans consulte aux urgences médicales pour crise d'asthme, l'attitude thérapeutique appropriée est :

- A. L'administration de bécloéthasone par inhalation
- B. L'administration de cromoglycate disodique par inhalation
- C. L'injection intraveineuse rapide de théophylline
- D. L'administration de salbutamol par inhalation
- E. L'injection de sédatif

13. Les signes de gravité d'une crise d'asthme sont :

- A. Une bradycardie
- B. Une cyanose
- C. Un tirage intercostal
- D. Un syndrome cave supérieur
- E. Des râles sibilants diffus intenses et bilatéraux

14. L'asthme bronchique est une affection caractérisée par :

- A. Des crises de dyspnée sifflante
- B. Un trouble ventilatoire obstructif partiellement réversible
- C. Une baisse importante de la DLCO
- D. Une hyper réactivité bronchique lors du test de provocation à la métacholine
- E. Une évolution vers la fibrose interstitielle diffuse

15. L'asthme aigu grave peut être traité par :

- A. Oxygénothérapie à faible débit
- B. Du sulfate de magnésium
- C. Des nébulisations de salbutamol
- D. Une perfusion d'hémisuccinate d'hydrocortisone à la dose de 1 mg/Kg/j
- E. Des bouffées de cromoglycate de sodium

16. Les facteurs suivants peuvent déclencher une crise d'asthme :

- A. La fumée de tabac
- B. L'exercice physique
- C. Des nébulisations par du bricanyl
- D. Les médicaments bêta bloquants
- E. Les viroses respiratoires

17. La crise d'asthme de l'adulte :

- A. Est précédé de prodromes
- B. Survient pendant la nuit
- C. Est caractérisée par une orthopnée
- D. Est soulagée rapidement par l'inhalation de Béta2 mimétiques
- E. Est accompagnée de bronchorrhée

18. Un asthme aigu grave peut être du à :

- A. Abus de sympatho mimétiques
- B. Exposition allergénique
- C. Sevrage d'une corticothérapie au long cours
- D. Prise d'aspirine ou d'AINS
- E. Prise de paracétamol

19. Concernant le traitement de la maladie asthmatique:

- A. L'utilisation des b2mimétiques par voie sous cutanée est indiquée au cours d'une crise légère
- B. Les corticoïdes par voie IV peuvent être utilisés seuls au cours d'une crise d'asthme
- C. Les Béta2mimétiques peuvent être utilisés par voie nébulisée
- D. Les anti cholinergiques longue durée d'action sont indiqués dans le traitement de fond quelque soit le palier
- E. Les anti leucotriènes constituent une alternative thérapeutique

20. Quels sont les 2 principaux examens permettant chez un asthmatique l'identification d'allergènes ?

- A. Test d'inhibition de la migration des macrophages
- B. Tests cutanés allergologiques
- C. Recherche des IgE totales
- D. Recherche des IgE spécifiques
- E. Dosage du complément sérique

21. Parmi les objectifs du traitement de fond de l'asthme :

- A. Obtenir le contrôle des symptômes
- B. Maintenir une fonction respiratoire proche de la normale
- C. Prévenir la mortalité liée à l'asthme
- D. Prendre en charge les exacerbations
- E. Diminuer des doses des corticoïdes inhalés

22. Parmi les éléments cliniques suivants, le (s) quel (s) vous permet (tent) d'évoquer le diagnostic d'asthme ?

- A. Crises de dyspnée paroxystique
- B. Sinusite chronique
- C. Prédominance nocturne des crises
- D. Les râles sibilants
- E. Sensation d'oppression thoracique

23. La crise d'asthme :

- A. survient fréquemment en pleine journée
- B. est souvent précédée par certains prodromes
- C. la résolution de la crise nécessite toujours l'administration d'un traitement bronchodilatateur
- D. L'examen physique trouve une bradypnée inspiratoire
- E. Elle peut être déclenchée par l'exposition à de la fumée de tabac

24. Dans l'asthme bronchique :

- A. La radio thorax peut être normale
- B. un déficit ventilatoire restrictif est trouvé à la Spirométrie
- C. On trouve une réversibilité partielle inférieure à 10 % du TVO après l'administration de bronchodilatateurs
- D. La réversibilité du TVO est définie par l'augmentation de la CPT de 200 ml et de 12%
- E. La réversibilité totale peut disparaître dans l'asthme sévère

25. Devant une dyspnée sifflante, les diagnostics à évoquer:

- A. Une pleurésie
- B. Un asthme bronchique
- C. Une BPCO
- D. Un adénocarcinome broncho pulmonaire périphérique
- E. Un dysfonctionnement des cordes vocales

26. Les Béta 2 stimulants :

- A. Ils entraînent une broncho-dilatation jusqu'aux voies aériennes proximales seulement
- B. ils améliorent l'activité muco-ciliaire
- C. ils améliorent la contractilité du diaphragme
- D. Ils peuvent entraîner une hypokaliémie
- E. Les B2LA ne sont indiqués qu'en traitement de fond.

27. Le traitement de fond de l'asthme

- A. Son principal objectif est d'obtenir et maintenir le contrôle de l'asthme
- B. Comporte 5 paliers thérapeutiques
- C. le traitement par bêta2-agonistes courte durée d'action(SABA) seul est recommandé
- D. Si l'asthme n'est pas contrôlé il faut toujours passer au palier suivant directement
- E. Pendant la grossesse, les patientes doivent être examinées tous les 3 à 6 mois.

28. En cas d'asthme bronchique :

- A. Le rapport VEMS/CVF < limite inférieure de la normale (LIN)
- B. Le test de bronchodilatation est défini par une réversibilité du VEMS < 12%
- C. Les données spirométriques peuvent être dans les normes
- D. Le test de provocation bronchique est indispensable pour confirmer le diagnostic
- E. Le DVO est fixe

29. En faveur de l'asthme allergique :

- A. le tabagisme
- B. recrudescence nocturne des symptômes
- C. l'association à une rhino conjonctivite allergique
- D. le début de la symptomatologie à un âge avancé
- E. Notion d'atopie familiale

30. Une jeune femme de 17 ans se présente à votre consultation pour des symptômes respiratoires récidivants survenant 1 à 2 fois par semaine à type d'essoufflement avec sifflements intrathoraciques s'améliorant spontanément en 5 à 10 minutes.

En l'absence d'argument clinique retrouvé pour un diagnostic différentiel, vous évoquez le diagnostic d'asthme. Elle fume 10 cigarettes par jour et ne veut pas arrêter de fumer.

Parmi les propositions de prise en charge ci-dessous, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. il faut instaurer un traitement inhalé sans attendre la réalisation d'une spirométrie
- B. il faut proposer un sevrage tabagique complet et définitif malgré ses réticences
- C. il faut débuter par un bronchodilatateur de courte durée d'action en monothérapie à la demande
- D. il faut limiter la pratique d'une activité physique
- E. il faut rédiger un plan d'action sur la conduite à tenir en cas d'exacerbation

31. Parmi les facteurs de risque suivants, le(s)quel(s) est(sont) associé(s) à un risque de décès par asthme ?

- A. obésité
- B. absence de traitement de fond par corticoïdes inhalés
- C. tabagisme actif
- D. Allergie au lait de vache
- E. antécédent d'asthme aigu grave avec séjour en réanimation

Cas clinique 1 :

Femme âgée de 25 ans, consulte aux urgences pour dyspnée sifflante paroxystique. Elle est asthmatique depuis l'âge de 4 ans, mal suivie, prend du budésonide 200 µg et du formotérol. Depuis deux semaines, elle a recours au salbutamol plusieurs fois tous les jours ; elle se réveille plusieurs fois par nuit et n'arrive plus à travailler normalement.

A l'examen, la patiente répond aux questions en reprenant sa respiration à chaque phrase. Elle est polypneique à 26 cycles/minute ; tachycarde à 105bpm ; l'auscultation pulmonaire révèle des râles sibilants bilatéraux ; le DEP est à 380L/minute (65% de la valeur théorique) ; la SatO2 est à 94%.

Le diagnostic d'une exacerbation modérée d'asthme a été posé. quels sont les éléments permettant de retenir ce diagnostic ?

- A. Le DEP à 65% de la valeur théorique
- B. La fréquence respiratoire à 26 cycles/min
- C. La fréquence cardiaque à 105 bpm
- D. Le recours au salbutamol plusieurs fois par jour
- E. La difficulté de parler

Quel traitement proposez-vous en urgence

- A. Le Salbutamol en nébulisation
- B. Le Formotérol en nébulisation
- C. Une ventilation mécanique
- D. La théophylline par voie orale
- E. Les anti-leucotriènes (montélukast) par voie orale

Après 24H de surveillance, la patiente est stable, un retour à domicile est préconisé. Quel(s) est (sont) le (s) traitement(s) de fond que vous proposez ?

- A. Un cortistéroïde inhalé à faible dose + un bronchodilatateur de longue durée d'action
- B. Un anticholinergique de longue durée d'action seul
- C. Un cortistéroïde inhalé à dose moyenne + un bronchodilatateur de longue durée d'action
- D. Un B2 mimétique courte durée d'action à la demande
- E. un bronchodilatateur de longue durée d'action + une corticothérapie orale à faible dose

Cette patiente présente un asthme non contrôlé. D'après l'énoncé, quels sont les éléments de mauvais contrôle de son asthme ?

- A. Les réveils nocturnes fréquents
- B. L'évolution de la symptomatologie depuis deux semaines
- C. L'utilisation de salbutamol plusieurs fois par jour
- D. La difficulté à effectuer son travail normalement
- E. L'évolution de l'asthme depuis l'âge de 4 ans

Cas clinique 2 :

Madame WA consulte les urgences pour une crise d'asthme. Elle parle difficilement, sa fréquence respiratoire est à 32 cycles par minute, son pouls est à 130 par minute, sa saturation est de 85% à l'air ambiant et son DEP est à 40% de la théorique.

Elle rapporte qu'elle est gênée presque tous les jours depuis une semaine une fois la nuit et qu'elle vit seule, et a un travail instable.

Depuis 48 heures, elle présente des crachats jaunâtres.

1. La CAT chez cette patiente :

- A. Administration d'oxygène 6 à 8l/min.
- B. Corticoïdes IV
- C. Ventilation mécanique
- D. Nébulisations par du tiotropium
- E. Injection du Sulfate de magnésium : 1,2 à 2g sur 20 minutes.

2. Quels sont les facteurs déclenchants de cette crise:

- A. Infections virales des voies aériennes
- B. Reflux gastro-oesophagien (RGO)
- C. Facteur psychologique
- D. Tabagisme
- E. Sinusite chronique

3. Après hospitalisation, la patiente est stable, un retour à domicile est préconisé, la CAT:

- A. Mettre la patiente sous Corticoïde inhalé à forte dose seul
- B. Mettre la patiente sous association corticoïde inhalé à dose faible et bronchodilatateur à courte durée d'action
- C. Mettre la patiente sous association corticoïde inhalé à dose faible et bronchodilatateur à longue durée d'action
- D. Mettre la patiente sous association corticoïde inhalé à dose faible et un anti leucotriènes.
- E. Faire un test de provocation bronchique pour faire le diagnostic d'asthme.

Cas clinique 3 :

Une femme de 26 ans consulte pour une dyspnée sifflante. Elle est tabagique 10 PA et a comme antécédents, plusieurs bronchiolites dans l'enfance, une rhinite saisonnière. Elle prend régulièrement du salbutamol depuis l'adolescence qui l'améliore lorsqu'elle est essoufflée. Elle vous raconte qu'elle se sent plus essoufflée depuis son retour de vacances deux mois plus tôt, vacances au terme desquelles elle a ramené un petit chat chez elle. Actuellement, elle prend 6 à 8 bouffées de salbutamol par jour, elle se réveille fréquemment la nuit à cause de quintes de toux et de sifflements dans la poitrine, et se sent gênée pour ses activités quotidiennes malgré une automédication par prednisolone à 40 mg pendant 3 jours 2 semaines plus tôt. Elle dit connaître très bien sa maladie, se traite toute seule et veut « juste une prescription » d'aérosol au domicile 3 fois par jour. Votre examen physique ne révèle que des sifflements en fin d'expiration. Le DEP mesuré au cabinet est à 60% de la valeur théorique.

1-quels sont les éléments de l'énoncé en faveur de l'asthme ?

- A. Terrain
- B. Tabagisme
- C. Toux et sibilants nocturnes
- D. Réponse au traitement Bronchodilatateur
- E. Recours fréquent aux B2CDA

2-quels sont les éléments en faveur du non contrôle de l'asthme ?

- A. Réveils nocturnes
- B. Symptômes diurnes
- C. Tabagisme
- D. Recours aux corticoïdes
- E. Recours fréquent aux B2 mimétiques

3- Quel(s) est (sont) le (s) traitement(s) de fond que vous proposez ?

- A. Un cortistéroïde inhalé à faible dose + un bronchodilatateur de longue durée d'action
- B. Un anticholinergique de longue durée d'action seul
- C. Un anticholinergique de longue durée d'action + antileucotriènes
- D. Un B2 mimétique courte durée d'action à la demande
- E. Un bronchodilatateur de longue durée d'action + une corticothérapie orale à faible dose